

개선요구 및 통보

제 목 진료재료 도입 및 운영 미흡

소 관 기 관 본사 □□□□실, ■■■○○○병원

조 치 기 관 본사 □□□□실, ■■■○○○병원

내 용

1. 업무개요

우리 공단은 환자 진료에 필요한 신규 진료재료 도입 시, 운용의 투명성과 효율성을 제고하고자 병원 내 자체 진료재료관리위원회의 심의를 거치고 있고, 특히 예정 금액이 크거나 2개 이상의 ■■■병원에서 공통으로 사용하는 진료재료에 대해서는 중앙구매를 진행하여 행정 업무의 효율성을 높이고 예산 절감을 도모하고 있다.

이러한 방침에 따라, 2025년 기준 ■■■병원 위생재료 중앙구매 대상 품목으로 총 **개 그룹 ***종(고시금액 미만 **개 그룹 ***종, 고시금액 이상 **개 그룹 **종)에 대한 입찰을 진행하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

■■■○○○병원은 원내 「진료재료관리위원회 운영지침」 제8조(신규진료재료의 사용신청) 및 제9조(진료재료선정기준)에 따라, 임상 진료과장이 필수 구비서류를 첨부하여 신청한 품목에 대해 병원장의 승인을 득하고 있으며, 같은 지침 제12조(단가계약대상품목선정)에 따라 고비용·다빈도(연 2회 이상 사용, 1회 50만 원 초과) 품목은 단가계약 대상으로 선정하고 있다.

따라서 신규 진료재료 도입을 위한 품목 선정 시, 원내외 규정을 준수함은 물론 기존 사용 진료재료의 유무, 예상 소요량 및 실제 사용량 등을 정확히 파악하여 진료재료 운용의 투명성과 효율성 제고에 만전을 기하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2026년 ■■■■■병원 종합감사에서 2024년부터 2026년까지의 원내 진료재료관리위원회 심의 안건 및 신규 진료재료 도입 내역을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 진료재료 단종에 따른 대체품목 도입에 관한 사항

건강보험심사평가원의 「치료재료 등재 및 사전상담 가이드라인」에 따르면 식약처 허가번호(허가증) 단위로 1개의 보험코드(EDI)를 부여하는 것을 원칙으로 하며, 분류 기준은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 치료재료 분류체계 가이드

명칭	대분류(**개)		중분류(품목군, **개)			소분류		
코드자리	1	2	3	4	5	6	7	8
코드예시	B	1	0	0	1	0	0	1
	자동봉합기		Linear Stapler			000000		
의미	사용목적과 용도에 따른 분류		기능, 용도, 형태, 재질, 규격 등에 따른 기준			제품별 구분		

※ 「치료재료 등재 및 사전상담 가이드라인」 예시 발췌

따라서 ■■■■■병원은 원내에서 사용하던 진료재료가 수입 불가, 단종 등의 사유로 변경이 필요한 경우, 단순히 기존 거래처가 제안하는 특정 품목만을 수용해서는 아니되며, 동일 EDI(보험) 코드 내에 등재된 대체 가능한 여러 품목의 단가, 품질, 적합성과 진료과의 진료재료 변경요구 품목 등을 종합적으로 비교·검토하여 최적의 제품을 선정해야 한다.

그런데 ■■■■■병원의 진료재료 대체 품목 변경 내역을 점검한 결과, 20**년 **월 제*차 진료재료위원회를 통해 도입된 슬관절강 내 주입용 치료재료 ‘슈벨트(M2094011)’와 관련하여 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

20**년 **월 **일, 기존 거래처(★★★)는 제조사(☆☆☆)와 판매사(○○○) 간의 문제로 인한 공급 차질을 사유로 타 EDI 코드 제품인 ‘틸리이드K(M2094163)’로의 변경 계약을 요청하는 공문을 발송하였고, ↔↔↔↔↔실은 주 사용 진료과(===과)의 승인만을 근거로 별도의 심의 없이 해당 품목으로의 변경 계약을 체결(2025. 2. 7.)하였다.

그러나 [표 2]에서 보듯 기존 품목(슈벨트)과 동일한 EDI 코드 내에는 판매사만 다를 뿐 대체 가능한 제품이 다수 존재함에도 병원 측은 업체가 요청한 사항에 대해 진료과의 승인에만 의존했을 뿐, 동일 EDI 코드 내 타 제품군에 대한 자체적인 비교·검토 절차를 하지 않았다.

[표 2] ■■■■■병원 슬관절강 내 주입 치료재료 대체품목 변경사항

EDI 코드	품명	제조회사	재질	비고

※ 건강보험심사평가원 요양기관업무 포털 내 치료재료대정보 발취

따라서, 진료재료의 공급 중단 및 판매 종료 등의 사유로 부득이하게 타 제품으로 대체해야 할 경우, 기존 납품업체(특정 업체)의 제안에 의존하기보다는

해당 품목과 동일한 EDI 코드가 부여된 진료재료들을 우선적으로 파악하고 검토하여 대체 품목을 선정하는 등 진료재료 운용 관리에 만전을 기할 필요가 있는 것으로 판단된다.

나. 중앙구매 단가계약 대상품목 선정에 관한 사항

우리 공단은 *개 ■■■병원에서 사용하는 진료재료의 표준화 및 중앙구매 품목 선정 심의 등 진료재료 운용의 효율성을 도모하기 위하여 「중앙진료재료 심의위원회」를 운영하고 있다.

공단 「중앙진료재료 심의위원회」 제10조(중앙구매 단가계약 대상품목 선정)에 따르면, 단가계약 품목 선정은 통상 연 1회(연말 또는 연초) 진행하며, 확정된 선정 품목 리스트를 각 병원 관리부(중앙■■■병원은 물류지원부)에서 본사 ※※※※부에 구매 요구하도록 명시하고 있다.

또한 본사 ※※※※부는 중앙구매 대상 품목 선정 기준으로 통상 2개 병원 이상에서 사용하고 구매금액이 2천만 원 이상인 품목을 우선 대상으로 하되, 기존 중앙구매 품목 그룹에 포함되거나 특별한 사유가 인정되는 경우에는 예외적으로 중앙구매로 편입하여 입찰을 진행한다고 안내한 바 있다.

따라서 각 ■■■병원은 원내 진료재료 사용 현황 및 향후 소요량을 면밀히 분석하여, 2개 병원 이상 사용 및 연간 2천만 원 이상 소요되는 품목 등 본사의 중앙구매 요건을 충족하는 재료가 누락되지 않도록 적기(연말 또는 연초)에 본사에 구매 요구를 해야 하며, 이를 통해 진료재료 운용의 효율성을 높이고 예산 절감에 만전을 기하여야 한다.

그런데 ■■■㉠㉠병원의 자체 단가계약 품목이었던 ‘릴리이드K(M2094163)’의 타 ■■■병원의 운영실태를 점검한 결과, [표 3]과 같이 5개 병원 모두 동일한 EDI 코드(M2094163)를 사용 중이나 병원별로 구매하는 제품명이 상이하였다.

특히 부산■■■병원의 경우 ■■■㉠㉠병원과 동일한 제품(릴리이드K)을 사용하고 있음에도 자체계약 기간이 남아 있어 중앙계약에 편입되지 못하였고, 결과적으로 ■■■㉠㉠병원 단독으로 중앙계약을 체결한 사실이 확인된다.

[표 3] ■■■병원 내 릴리이드K 동일 EDI코드 진료재료 사용 현황(2025.10.1. 기준)

병원명	수가코드	수가명	EDI	단가(원)	비고

※■■■㉠㉠병원 제출자료 각색

이와 관련하여, 중앙구매 대상 품목으로 선정되는 과정을 확인해 본 결과, ■■■병원의 구매담당자가 타 ■■■병원의 동일 품목 사용 여부 및 자체계약 기간 등 운영 실태를 실무자 간 비공식적인 방식(유선통화, 메신저 등)으로 파악하고 있어, *개 병원의 정확한 소요량, 동일 EDI 코드 내 대체 제품 현황, 병원별 계약 만료일 등을 체계적으로 파악하고 조율하는 데 한계가 발생할 수밖에 없었다.

따라서 중앙구매 단가계약 대상 품목 선정을 위한 수요 파악 및 의견조회는 총괄 부서인 본사 ※※※※부가 주도적으로 수행하여야 할 필요성이 있으므로 중앙구매 계약 추진 시 *개 ■■■병원 전체를 대상으로 공식적인 사전 수요조사

를 실시하고, 각 병원의 진료재료 운용 현황과 계약 만료 시점을 종합적으로 분석하여 중앙구매 편입 요건 충족 여부를 검토하는 등 일부 병원이 누락되지 않도록 관련 절차를 개선할 필요가 있다.

아울러, [표 3]에 언급된 릴리이드K 중앙계약과 관련하여 감사기간 중 ↔↔↔↔↔↔실 및 구매부서 담당자는 “환자 진료의 질적 향상과 안전을 위해 실제 임상 현장에 있는 전문의의 진료재료 선택권 및 처방권이 우선 존중되어야 하며, 동일 보험코드 내 다수의 제품명이 존재하는 경우 강제적인 품목 통일보다는 병원 별 진료과(처방의)의 선호도를 반영하여 개별 운영하는 것이 합리적”이라는 의견을 제시하였다.

이와 관련하여 본사 ※※※※부는 1개의 보험코드에 다수의 제품명이 등록된 품목에 대하여 *개 ■■■병원의 공식적인 의견조회 및 협의 과정을 거쳐 가장 합리적인 구매 및 운영 방안 마련이 필요한 것으로 판단된다.

다. 진료재료 심의위원회 운영에 관한 사항

본사 ※※※※부 및 ■■■○○○병원은 진료재료의 선정 심의, 사용, 관리 등 진료재료 운용의 효율성을 제고하기 위하여 각각 「중앙진료재료 심의위원회」와 「진료재료관리위원회」를 운영하고 있으며, 각 위원회의 구성 및 운영 기준은 [표 4]와 같다.

[표 4] 진료재료 심의위원회 구성 및 심의사항 등

구분	중앙진료재료 심의위원회 운영지침 (본사 ※※※※부)	진료재료관리위원회 운영지침 (■■■○○○병원 ↔↔↔↔↔↔실)
위원회 구성		

기능	1. 진료재료 표준화에 관한 사항 2. 중앙구매 연간 단가계약 품목의 선정과 사용제도에 관한 사항 3. 진료재료의 제반 신정보의 수집, 검토, 심의에 관한 사항 4. 진료재료 자료집, 제작 배포 등에 관한 사항 5. 진료재료 사용실적 관리 등 사후관리에 관한 사항 6. 기타 진료재료 관련 업무 사항으로 위원장이 심의 제안한 안건	1. 신규 진료재료 선정에 관한 사항 2. 연간 단가계약 품목의 선정과 사용제도에 관한 사항 3. 장기재고 진료재료 조치에 관한 사항 4. 진료재료에 대한 제반신정보의 검토, 심의에 관한 사항 5. 병원 진료재료 자료집, 작성 등에 관한 사항 6. 진료재료 과다사용에 대한 원인규명 및 조치에 관한 사항 7. 기타 진료재료 업무에 관한 사항으로 위원장이 제의한 안건
회의	정기 회의는 연 2회(반기 1회) 개최 원칙	분기 1회 이상 정기 개최함이 원칙
서면결의	위원장이 긴급하거나 경미하다고 인정되는 사항에 관하여는 서면 의결	위원장이 긴급하거나 경미하다고 인정되는 사항에 관하여는 서면 의결

따라서 본사 ※※※※부 및 ■■■■■병원은 진료재료 운용의 효율성을 높이기 위해 진료재료 선정의 타당성 검토를 비롯하여 적정 사용량 모니터링, 장기재고 및 과다 사용 원인 규명 등 전반적인 사후관리에 대하여 실질적인 관리·감독을 수행하여야 한다.

그런데 본사 ※※※※부 및 ■■■■■병원의 위원회 개최 내역을 점검한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

■■■■■병원은 분기 1회 이상 대면 개최가 원칙임에도 불구하고 「진료재료관리위원회」를 전면 서면결의로만 대체하여 운영하여, 신규 진료재료 도입 및 진료재료 과다 사용 원인 규명 등에 대한 심도 있는 대면 심의와 논의가 전혀 이루어지지 않았다.

또한, 본사 ※※※※부의 「중앙진료재료 심의위원회」 역시 연 2회 정기 개최가 원칙임에도, 20**년 **월 입찰 참가 *개 업체의 규격 적격자 선정을 위한 1차 회의를 진행한 이후 현재까지 단 한 차례도 위원회를 개최하지 않은 것으로

확인되었다.

관계기관 의견

■□□ⓂⓂ병원에서는 별도의 의견을 제시하지 아니고 감사 의견을 수용하였으나, 본사 ※※※※부에서는 다음과 같은 의견서를 제출하였다.

(나)항과 관련하여, 진료재료 통합 계약이 예산 절감과 행정 효율성을 높이는 장점이 있으나, 의료진의 전문적 판단에 따라 유동적인 구매가 필요한 일부 품목은 중앙구매 방식보다는 병원 자체 계약으로 운영하는 것이 적합한 것으로 판단되고,

특히 ‘릴리이드K’와 같은 슬관절강내 주입용 주사제는 제조사 및 성분에 따라 종류가 다양하여 환자에게 주사제 투여 시 임상적 효과를 최우선으로 고려하므로,

만약 중앙구매 입찰 시 이러한 진료재료의 특수성을 고려하지 않고 동일 보험코드 기준으로 묶어 입찰을 진행할 경우, 입찰참가 업체들이 단가 하락을 위해 특정 제조사의 품목이나 저가 제품 위주로 투찰할 우려가 있으므로 결국 의료진이 실제 임상에서 필요로 하는 진료재료를 구매하지 못하거나 적기에 도입하지 못하는 결과로 이어질 수 있다는 의견과 더불어 환자의 신체에 직접 주입되어 치료 효과와 직결되는 민감한 진료재료에 대해서는 각 병원이 자체 계약을 통해 진료 환경 및 환자 상태에 맞춰 유연하게 운영하는 것이 효율적이라는 의견을 제시하였다.

또한 (다)항과 관련하여, 「중앙진료재료 심의위원회 운영지침」상 연 2회 정기 개최 규정을 현실적으로 준수하기 어렵다고 답변하였다. 진료재료 중앙구매는 연간 **개 분류에 대해 순차적으로 입찰을 진행하며, 2025년 기준 총 *,***종(약 ***억 원 규모)을 구매하고 있어, 각 입찰 건별 계약 업무가 연중 지속해서

발생하고 있으므로 특정 시점을 정해 정례적으로 위원회를 개최하는 것은 실제 구매 업무 여건과 맞지 않다는 의견과 함께 중앙구매 대상 품목은 이미 각 병원의 진료재료관리위원회를 거친 신규 품목을 대상으로 편입 여부를 검토하기 때문에 중앙진료재료 심의위원회를 별도로 운영하는 것은 업무 중복 소지가 있다고 의견을 제시하였다.

아울러, § § 이사 및 □□□□실장을 비롯하여 6개 병원 진료실장, ↔↔↔↔↔ 실 과장 등 다수 위원의 참석 일정을 동시에 조율하는 것은 현실적으로 곤란하다는 의견을 제시하였다.

그러나 ※※※※부는 현재 병원에서 사용하는 의료장비, 의약품 등 구매와 관련 심의위원회인 중앙의약품심의위원회 및 중앙의료장비심의위원회를 운영 중으로 타 심의위원회 역시 외부위원과 *개 병원의 주요 보직자(☎☎실장, ☎☎실장, ☎☎☎☎과장 등) 다수가 참석하여 원활히 개최되고 있다. 이를 감안할 때, 다수 위원의 일정 조율이 곤란하다는 사유는 ※※※※부 내 타 위원회 운영형태와 비교해 보았을 때 설득력이 부족한 것으로 판단된다.

또한, ※※※※부에서는 지침이 제정된 20**년 이후 실제 위원회가 개최된 사례는 앞서 언급한 20**년 **월(봉대류 규격평가 관련) 단 1회뿐이었고, 현재의 업무 여건상 위원회 운영의 실효성이 낮다고 판단하며, 현 운영 실태와 업무 효율성 등을 종합적으로 고려할 때 「진료재료 심의위원회 운영지침」을 폐지하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

그러나 중앙진료재료 심의위원회는 [표 4]와 같이 진료재료 전반(표준화, 중앙구매 단가계약 품목 선정·사용, 신규 정보 수집·심의, 자료집 제작·배포, 사용 실적 관리 등)에 대한 핵심 심의 기능을 담당하고 있으므로, 해당 심의위원회를

폐지할 경우 본사 차원의 *개 ■■■병원 진료재료 구매에 대한 내부통제 기능을 상실하게 되므로 위원회 운영지침을 폐지하는 대신 운영의 내실화 및 현행화를 도모하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

§§이사는

(나)사항과 관련하여,

① 중앙구매 단가계약 추진 시, 본사 ※※※※부 주관으로 *개 ■■■병원 전체를 대상으로 공식적인 수요조사 및 계약 현황 분석을 실시하여 중앙구매에서 누락되는 일이 없도록 관련 업무 절차를 개선하시기 바라며, (개선)

② 진료재료 도입 시 행정 효율성과 예산 절감을 위한 중앙구매를 원칙으로 하되, 1개의 보험코드 내에 여러 제품명이 존재하는 진료재료의 구매 방법에 대하여 *개 병원의 의견조회를 하시기 바라고, (통보)

(다)사항과 관련하여, 본사 차원의 *개 ■■■병원 진료재료 구매에 대한 내부통제 기능이 상실되지 않도록, 중앙의료장비 심의위원회 운영의 내실화 및 관련 규정 현행화 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

■■■○○○병원장은

(가)사항과 관련하여, 부득이한 사유로 진료재료를 대체할 경우 특정 납품업체에 의존하지 않도록 원내 「진료재료관리위원회 운영지침」을 개정하여 대체 품목 지정 및 변경에 대한 자체 검토 절차를 명문화함으로써 진료재료 운용의 투명성을 확보하시기 바라며, (개선)

(다)사항과 관련하여, 「진료재료관리위원회」 운영 시 서면심의에만 의존하지 않

고 대면심의를 활성화하여 원내 사용 진료재료에 대한 위원 간의 심도 있는 의견 교환을 통해 위원회를 내실 있게 운영하시기 바랍니다. (통보)